

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (RSES-10)

Eje III: Personalidad • Evaluación Dimensional del Autoconcepto Global y la Autovaloración Personal

### 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Oficial (Español)</b> | Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES: 10 reactivos).                                     |
| <b>Nombre Original</b>          | Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES; Rosenberg, 1965).                                        |
| <b>Autor Original</b>           | Dr. Morris Rosenberg (Universidad de Princeton / Universidad de Maryland, EE. UU.).         |
| <b>Adaptaciones Hispanas</b>    | Atienza et al. (2000), Univ. de Valencia; Martín-Albo et al. (2007); Vázquez et al. (2004). |
| <b>Eje Clínico y Constructo</b> | Eje III: Personalidad. Autoestima global, valía personal subjetiva y autoaceptación.        |
| <b>Tipo de Instrumento</b>      | Autoinforme unidimensional de 10 reactivos con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).           |
| <b>Población y Rango</b>        | Adolescentes y adultos (12 a 85 años). Población general y clínica ambulatoria.             |
| <b>Tiempo de Administración</b> | 2 a 4 minutos en autoadministración.                                                        |
| <b>Régimen de Licencia</b>      | Dominio público científico de libre administración clínica y docente bajo citación.         |

### 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DEL AUTOCONCEPTO

La Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES; Rosenberg, 1965) constituye el estándar de oro psicométrico global para la evaluación de la **autoestima global**, entendida como la orientación evaluativa global y afectiva positiva o negativa que un individuo mantiene hacia sí mismo ("sentimiento global de ser una persona digna y valiosa").

A diferencia de los inventarios multidimensionales de autoconcepto que segregan facetas académicas, físicas o sociales (ej. AF-5), la RSES captura el juicio sumatorio de autovalía que opera como pilar disposicional de la personalidad. Rosenberg concibió la escala enfatizando el equilibrio entre autoaceptación realista y orgullo adaptativo, integrando cinco reactivos formulados en dirección positiva y cinco en dirección negativa para neutralizar el sesgo de respuesta aquiescente.

Desde la óptica neurobiológica, la autoestima positiva se relaciona con una modulación óptima de la red neuronal por defecto (DMN), especialmente en la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada posterior durante tareas de autoreflexión. La baja autoestima crónica exhibe una hiperreactividad amigdalina ante rostros de crítica o rechazo social, menor volumen de materia gris en el hipocampo y una atenuación de la recompensa estriatal dopaminérgica ante el propio éxito.

### 3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

| Componente Evaluado               | Ítems (10)          | Nº Ítems | Definición Operativa y Enfoque Evaluativo                                            |
|-----------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Autoestima Positiva</b>     | 1, 2, 4, 6, 7       | 5 ítems  | Sentimiento de dignidad personal, orgullo por las cualidades y autoeficacia general. |
| <b>2. Autoestima Negativa (*)</b> | 3*, 5*, 8*, 9*, 10* | 5 ítems  | Sentimientos de fracaso, inutilidad personal, autodesprecio y carencia de méritos.   |

## PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

### 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia Interna</b>     | Excelente fiabilidad en la adaptación española de Atienza et al. (2000; N = 852): coeficiente alfa de Cronbach de 0.85 a 0.88 y omega de McDonald de 0.87. Estabilidad temporal test-retest $r = 0.84$ a un mes y $r = 0.74$ a un año, ratificando su consistencia disposicional.                                       |
| <b>Estructura Factorial</b>     | El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la unidimensionalidad teórica de la autoestima global cuando se modela el efecto de método asociado al redactado de los ítems negativos (CFI = 0.98, TLI = 0.97, RMSEA = 0.042; Vázquez et al., 2004).                                                                    |
| <b>Validez Concurrente</b>      | Correlación directa robusta con Autoeficacia General (GSE, $r = 0.62$ ), Optimismo (LOT-R, $r = 0.58$ ), Afecto Positivo (PANAS, $r = 0.51$ ) y Satisfacción Vital (SWLS, $r = 0.59$ ). Correlación inversa intensa con Depresión (PHQ-9, $r = -0.65$ ), Ansiedad (GAD-7, $r = -0.52$ ) y Soledad (UCLA, $r = -0.56$ ). |
| <b>Sensibilidad al Cambio</b>   | Sensible a intervenciones de Reestructuración Cognitiva, Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y Terapia Centrada en la Compasión (CFT), con incrementos de $d$ de Cohen $> 0.70$ tras abordaje terapéutico.                                                                                                         |
| <b>Invarianza Transcultural</b> | Invarianza de medida ratificada en más de 50 naciones (Schmitt & Allik, 2005), autorizando comparaciones clínicas transculturales válidas.                                                                                                                                                                              |

### 5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada ítem se califica en una escala Likert de 4 alternativas:

- **Opciones de Respuesta:** 1 = «Muy en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «De acuerdo», 4 = «Muy de acuerdo».
- **Paso 1 (Inversión de Ítems Negativos):** Los 5 reactivos negativos (**Ítems 3, 5, 8, 9 y 10**) se invierten:

$$\text{Ítem Invertido} = 5 - \text{Respuesta Original}$$

(De modo que: 1 pasa a 4; 2 pasa a 3; 3 pasa a 2; 4 pasa a 1).

- **Paso 2 (Puntuación Total RSES):** Suma aritmética de los 10 ítems (con los 5 negativos recodificados):

$$\text{Puntuación Total} = \sum_{i=1}^{10} \text{Ítem}_i$$

- **Rango Total Teórico: 10 a 40 puntos.** A mayor puntuación, mayor nivel de autoestima y sentimiento de autovalía personal.

### 6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

| Estratificación       | Puntuación Total | Nivel de Autoestima           | Significación y Conducta Clínica                                                                              |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baja / Frágil</b>  | 10 a 25 puntos   | Autoestima baja ( $\leq 25$ ) | Autodesprecio marcado, sentimientos de inutilidad e hipersensibilidad a la crítica. Foco clínico prioritario. |
| <b>Media / Normal</b> | 26 a 29 puntos   | Autoestima moderada           | Nivel adaptativo normativo; adecuada valoración propia con vulnerabilidad ante estresores severos.            |
| <b>Alta / Sólida</b>  | 30 a 40 puntos   | Autoestima elevada            | Firme convicción de dignidad y valía personal, resiliencia afectiva y seguridad interpersonal.                |

#### ALERTA CLÍNICA DE BAJA AUTOESTIMA (CORTE $\leq 25$ PUNTOS):

Una puntuación  $\leq 25$  en la RSES actúa como cofactor crítico de vulnerabilidad en cuadros de Depresión Mayor, Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y Fobia Social. En población infanto-juvenil y adolescente, predice ideación de escape e indefensión aprendida.

## APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

### 7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA BASADO EN LA RSES

#### PROTOCOLO DE FORTALECIMIENTO DEL AUTOCONCEPTO Y AUTOVALÍA:

- **Paso 1 (Detección del Patrón Evaluativo):** Si RSES  $\leq 25$ , explorar si el déficit se debe a ausencia de autovaloración positiva (ítems 1, 2, 4, 6, 7 bajos) o a una activa autocrítica hostil (ítems 3, 5, 8, 9, 10 con puntuación 4 invertida).
- **Paso 2 (Desactivación de la Crítica Interna y CFT):** En presencia de autoataque severo, aplicar Terapia Centrada en la Compasión (Gilbert): cambiar la autocrítica por voz autocompasiva y reestructuración de esquemas de defecto personal.
- **Paso 3 (Defusión y Aceptación en ACT):** Desvincular la autovalía del rendimiento o de la aprobación externa contingente ("Yo como contexto" vs. "Yo como contenido conceptualizado").
- **Paso 4 (Criterio de Recuperación):** Un incremento de  $\geq 7$  puntos o alcanzar el rango de autoestima moderada ( $\geq 26$  pts) consolida la resiliencia psicológica.

### 8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPRESIÓN Y ESQUEMA DE DEFECTUOSIDAD

**Identificación:** Mujer de 28 años, investigadora predoctoral, acude por rumiación depresiva, sensación de impostura intelectual ("siento que soy un fraude y tarde o temprano todos lo notarán") y aislamiento social tras recibir correcciones menores a un manuscrito.

**Evaluación Inicial RSES (Línea Base):** Puntuación Total = **17/40 puntos** (Autoestima Baja / Rango de Vulnerabilidad Crítica). Marcada elevación en autodesprecio (Ítem 5 "Siento que no tengo mucho de qué enorgullecerme" = 4; Ítem 8 "Desearía poder sentir más respeto por mí misma" = 4). PHQ-9 concurrente = 13 (depresión moderada).

**Plan Terapéutico:** 12 sesiones de TCC y Terapia de Esquemas enfocadas en el esquema de Defectuosidad/Vergüenza y síndrome del impostor. Se introdujo el registro diario de méritos y evidencias objetivas de competencia profesional, eliminando la sobregeneralización de fallos.

**Reevaluación al Cierre:** Puntuación Total RSES ascendió a **32/40 puntos** (+15 pts, Rango de Autoestima Elevada / Sólida). La paciente remitió totalmente la sintomatología depresiva (PHQ-9 = 3) y defendió con éxito su informe de avance académico sin ruminaciones autodescalificatorias.

### 9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

#### AUTOESTIMA CRÍTICA Y RIESGO AUTOLÍTICO:

Una puntuación RSES  $\leq 15$  denota un colapso total del sentimiento de dignidad personal y correlaciona de forma crítica con ideación de suicidio egodistónica (aplicar protocolo C-SSRS de inmediato).

#### AUTOESTIMA DEFENSIVA VS. NARCISISMO:

Puntuaciones máximas de 40/40 en pacientes que exhiben alta hostilidad interpersonal pueden reflejar autoestima defensiva inflada o narcisismo grandioso/frágil (contrastar con SD3 / SD4 / NPI-N).

### 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton University Press.
2. Atienza, F. L., Moreno, Y., & Balaguer, I. (2000). Análisis de la dimensionalidad de la Escala de Autoestima de Rosenberg en una muestra de adolescentes valencianos. *Revista de Psicología Social*, 15(3), 247-260.
3. Vázquez, A. J., Jiménez, R., & Vázquez-Morejón, R. (2004). Escala de Autoestima de Rosenberg: Fiabilidad y validez en población clínica española. *Apunt Psicol*, 22(2), 247-255.
4. Schmitt, D. P., & Allik, J. (2005). Simultaneous administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 nations: Exploring the universal and culture-specific features of global self-esteem. *JPSP*, 89(4), 623-642.